التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

تعرض مؤسسات صحية كثيرة على أطبائها أرقام أدائهم.

وفي مراجعة لتجارب عشوائية كثيرة، زاد اتباع ما توصي به الأدلة بنحو 6 نقاط مئوية في المتوسط.

لكن الأثر تفاوت كثيرًا. وهذا ما تعرضه خمس دراسات نُشرت بين عامي 2021 و2026.

← اسحب للمتابعة

الفكرة

ما التدقيق والتغذية الراجعة؟

هو أن يُقاس أداء الطبيب أو الفريق مدة محددة، ثم تُعرض عليه النتائج.

والنقطة المئوية هي الفرق بين نسبتين: فالانتقال من 50% إلى 56% زيادة بست نقاط مئوية.

جمعت المراجعة 292 تجربة عشوائية

6.2

هو متوسط الزيادة بالنقاط المئوية في اتباع ما توصي به الأدلة، في 177 تجربة قارنت من تلقّوا الأرقام بمن لم يتلقّوها.

2.7

هو الحد الذي لم يتجاوزه التحسن في نصف النتائج. وفي ربعها على الأقل لم يحدث تحسن. وهذا الرقم محسوب بطريقة أخرى، فلا يُقارَن بالمتوسط مباشرة.

وكان التحسن أكبر عند الأطباء الذين بدؤوا بأداء ضعيف.

وصف أطباء الرعاية الأولية مضادات أقل

11%

هي نسبة انخفاض كمية المضادات الحيوية عند من تلقّوا الأرقام، في 21 تجربة.

23%

هي نسبة انخفاض المرات التي بدأ فيها الأطباء مضادًا لا حاجة إليه، في 16 تجربة.

وهاتان النسبتان محسوبتان قياسًا إلى ما فعله الأطباء الذين لم يتلقّوا الأرقام، وليستا نقاطًا مئوية. ونبّه الباحثون إلى أن نتائج التجارب اختلفت كثيرًا.

Xu et al., Clin Infect Dis, 2025

نتائج متباينة

ولم يتحسن كل شيء

في أونتاريو بكندا، ارتفعت نسبة استئصال الزوائد عند أطباء التنظير في المجموعتين بقدر متقارب، لكن الأضعف أداءً ممن تلقّوا التقرير تحسّنوا أكثر.

وفي سبعة أقسام لطوارئ الأطفال، تحسّن تسجيل العلامات الحيوية، وساءت في الفترة نفسها سرعة الخدمة.

وفي 201 مركز لجراحة أورام المثانة، تحسّن تسجيل المعلومات الجراحية في المراكز التي تلقّت التقارير، ولم يختلف معدل عودة الورم.

متى كان الأثر أكبر؟

كان الأثر أكبر حين خصّت الأرقام الطبيب نفسه

وحين قارنت أداءه بأفضل زملائه أو بمستوى مرجعي محدد.

وحين عرضها شخص من مكان العمل يعرفه الطبيب من قبل.

وحين صاحبتها خطة فيها خطوات محددة للتحسين.

جاءت أكثر هذه النتائج من مقارنة التجارب بعضها ببعض، وقال الباحثون إنها تحتاج إلى تأكيد.

Ivers et al., Cochrane, 2026

ما يستنتجه الكاتب من الدراسات

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

يختار مؤشرًا مهمًا ما زال الأداء فيه بعيدًا عن المطلوب.

2

ويعرض على كل شخص أرقامه هو، ويناقشها معه شخص يعرفه، ومعها خطة محددة.

3

ويراقب مقاييس أخرى قد تسوء، لا المقياس المستهدف وحده.

الخطوات الثلاث استنتاج من الكاتب، ولم تختبرها أي دراسة مجتمعةً.

> **بعد ثلاث سنوات، أتريد أن تبقى تقارير الأداء في مؤسستك أوراقًا تُنسى، أم أن يراجع كل موظف أرقامه مع زميل يعرفه ويختاراً خطوة لتحسينها؟**

حدود هذه الأدلة

في 39% من تجارب مراجعة كوكرين خطر مرتفع للتحيز، أي خلل قد يجعل النتيجة غير دقيقة.

وتقيس المراجعة ما يفعله العاملون الصحيون، لا صحة المرضى.

ولم يذكر ملخص أيٍّ من الدراسات الخمس تجربة في دولة عربية، ونفع الفكرة في قطاعات أخرى استنتاج لم يُختبر بعد.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Ivers, N., et al. (2026). Audit and feedback: effects on professional practice. *Cochrane Database Syst Rev*, CD000259.

[2] Xu, A. X. T., et al. (2025). Audit and feedback interventions for antibiotic prescribing in primary care. *Clin Infect Dis*, 80(2), 253–262.

[3] Tinmouth, J., et al. (2021). A pragmatic RCT of an endoscopist audit and feedback report for colonoscopy. *Am J Gastroenterol*, 116(10), 2042–2051.

[4] Chamberlain, J. M., et al. (2025). Audit and feedback on pediatric emergency department performance measures. *Hosp Pediatr*, 15(11), 901–910.

[5] Gallagher, K., et al. (2026). RESECT: a randomised controlled trial of audit and feedback in bladder cancer surgery. *Eur Urol*, 89(4), 355–365.

المقال الكامل: tamayuz10x.com/article-oe-evidence-audit-and-feedback.html